

Estação 1

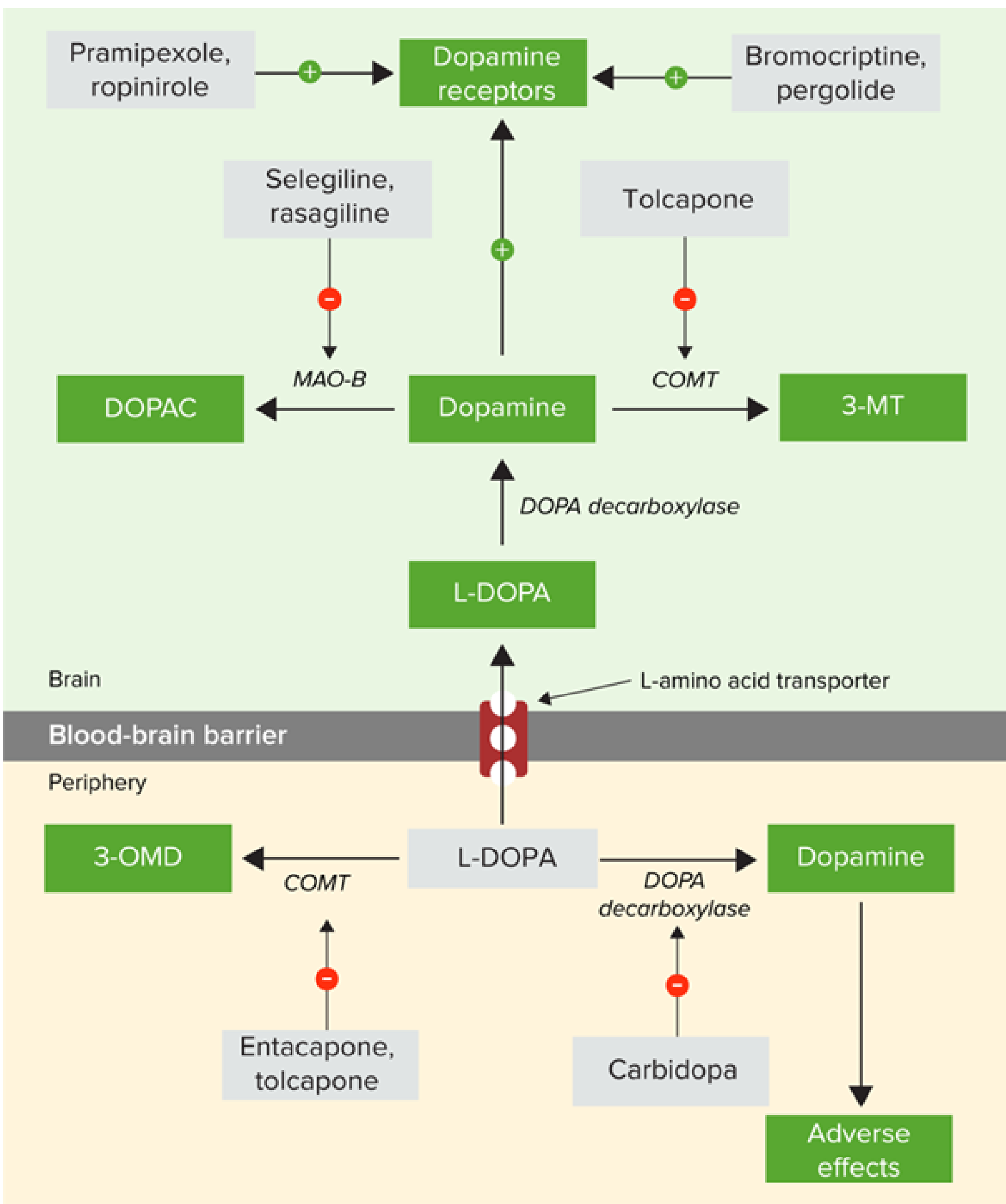
gabrielmarcio2003@gmail.com Alternar conta

✉ Não compartilhado

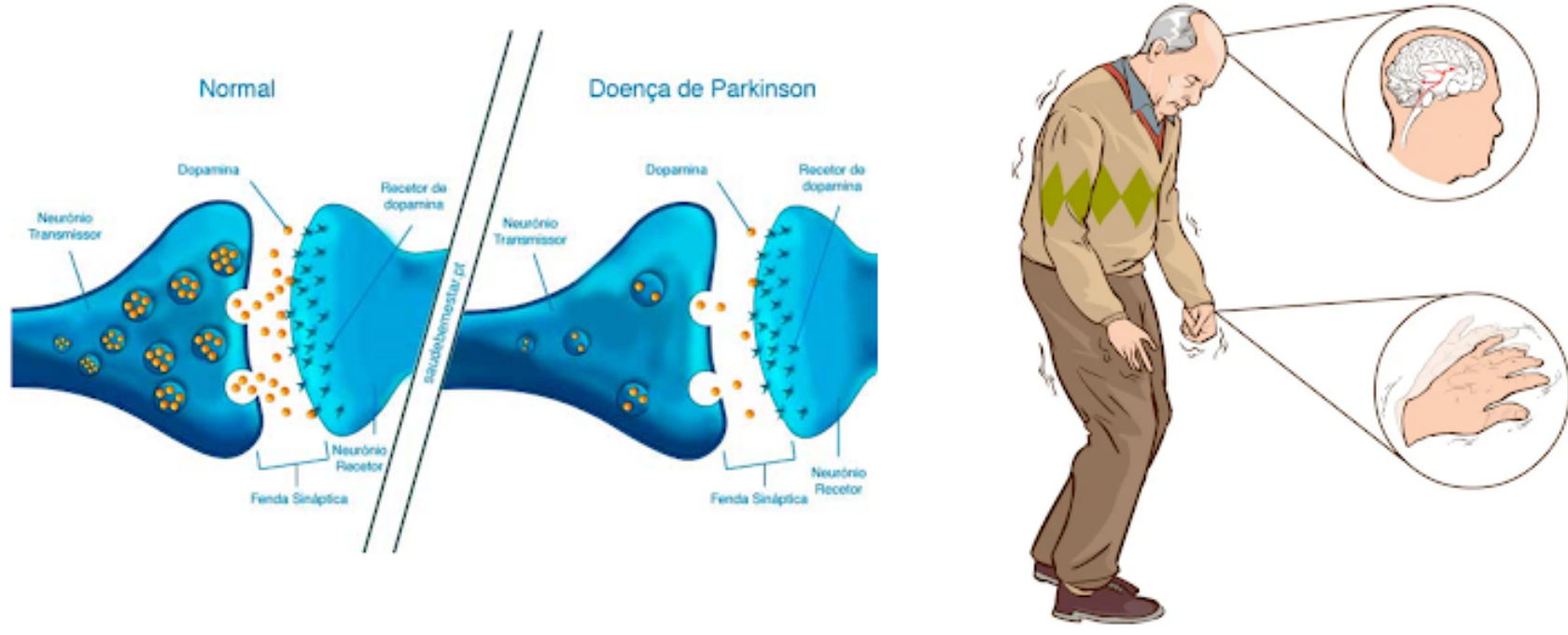
* Indica uma pergunta obrigatória

Estação 1

A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo do movimento muscular, caracterizado por tremores, rigidez muscular, bradicinesia (lentidão ao iniciar e executar movimentos voluntários) e anormalidades de postura e de marcha. A maioria dos casos envolve pessoas com mais de 65 anos, entre as quais a incidência é de 1 em 100 indivíduos. Vários dos fármacos disponíveis atualmente visam manter constantes os níveis de dopamina no SNC. Esses fármacos oferecem alívio temporário dos sintomas, mas não interrompem nem reverterem a degeneração neuronal causada pela doença.



Quais os mecanismos fisiopatológicos da doença de Parkinson? E os neurotransmissores envolvidos?



A doença de Parkinson é uma síndrome clínica neurodegenerativa da substância negra presente no sistema nervoso central. A clínica da doença de Parkinson se baseia em dois grandes grupos: os sintomas motores e sintomas não motores. Dessa forma, os sintomas motores clássicos da doença de Parkinson são tremor, bradicinesia, rigidez, alterações na marcha e no equilíbrio, controle dos movimentos oculares, fala e deglutição e controle da bexiga. Já os sintomas não motores, são aqueles que tangem o comportamento, cognição e sistema autônomo sendo aqueles que podem gerar fadiga, dor e gerando impacto na vida do paciente.

Correlacione os fármacos utilizados no tratamento da doença de Parkinson com seus respectivos mecanismos de ação.

	Levodopa	Carbidopa / Benserazida	Selegilina / Rasagilina	Entacapona e tolcapona	Bromocriptina, Pramipexol, Rotigotina
Inibe a Catepol-O-Metiltransferase (COMT) seletiva e reversivelmente. A inibição da COMT reduz a concentração de 3-O-metildopa no plasma, aumenta a captação central de levodopa e eleva as concentrações cerebrais de dopamina	☐	☐	☐	☒	☐
É um precursor metabólico da dopamina. Restabelece a neurotransmissão dopaminérgica no neostriado, aumentando a síntese de dopamina nos neurônios ainda ativos da substância negra.	☒	☐	☐	☐	☐
É um agonista dopaminérgico, age centralmente estimulando os receptores de dopamina.	☐	☐	☐	☐	☒
Inibe seletivamente a monoaminoxidase (MAO) tipo B (metaboliza a dopamina) em dose baixa ou moderada. Aumenta os níveis de dopamina no cérebro, diminuindo o metabolismo da dopamina.	☐	☐	☒	☐	☐
É um inibidor da dopamina-descarboxilase, diminui a biotransformação da levodopa na periferia, aumentando, assim, a disponibilidade de levodopa no SNC.	☐	☒	☐	☐	☐

Voltar

Próxima

Limpar formulário

Estação 1

gabrielmarcio2003@gmail.com [Alternar conta](#)

 Não compartilhado

 Rascunho salvo.

* Indica uma pergunta obrigatória

Estação 1

Explique o motivo e a importância da associação dos medicamentos prescritos para o paciente. *

É necessário a associação dos medicamentos, uma vez que o carbidopa inibe dopamina-descarboxilase, a qual transforma a levodopa em dopamina na corrente sanguínea e ocasiona os seus efeitos adversos

Por que a recomendação de que este medicamento seja administrado 30 minutos antes ou 1 hora após as refeições? *

Pois dessa forma a absorção do levodopa pode acontecer corretamente, uma vez que as proteínas competem para serem absorvidas no estômago

Voltar

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em UFRN. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

